PELVIS · PE-01

Prostate · PI-RADS v2.1

PI-RADS v2.1 · PI-QUAL v2
IRM multiparamétrique et biparamétrique

PRINCIPE · SÉQUENCE DOMINANTE SELON LA ZONE

Zone périphérique (ZP) → diffusion dominante

DIFFUSION	SCORE DCE	PI-RADS
1 · 2	indifférent	1 · 2
3	DCE négatif	3
3	**DCE positif**	4
4 · 5	indifférent	4 · 5

Zone de transition (ZT) → T2 dominant

T2	DIFFUSION	PI-RADS
1	indifférent	1
2	≤ 3 · **≥ 4**	2 · 3
3	≤ 4 · **5**	3 · 4
4 · 5	indifférent	4 · 5

Le DCE n'intervient pas dans la zone de transition.

SCORES PAR SÉQUENCE

Diffusion (ADC + b élevé ≥ 1 400)

1	Pas d'anomalie
2	Hyposignal ADC et/ou hypersignal b élevé **linéaire ou en coin** ; ou anomalie marquée sur une seule des deux images
3	Anomalie **focale** modérée (ADC légèrement à modérément bas), iso ou discrètement hyper en b élevé
4	Focale, **nettement** hypo ADC et nettement hyper b élevé, **< 1,5 cm**
5	Comme 4 mais **≥ 1,5 cm**, ou extension extraprostatique / comportement invasif

T2 · zone de transition

1	Signal intermédiaire homogène normal, ou **nodule encapsulé typique** (HBP)
2	Nodule **atypique** (en grande partie encapsulé ou circonscrit sans capsule), ou zone homogène discrètement hypo entre les nodules
3	Signal hétérogène à contours flous ; ce qui n'est ni 2, ni 4, ni 5
4	Lenticulaire ou non circonscrit, homogène, modérément hypo, **< 1,5 cm**
5	Comme 4 mais **≥ 1,5 cm**, ou extension extraprostatique

DCE (binaire)

Positif rehaussement **focal**, précoce ou simultané au tissu adjacent, correspondant à une anomalie T2 ou diffusion.
Négatif pas de rehaussement précoce, ou rehaussement diffus, ou correspondant à un nodule d'HBP.

Probabilité de cancer cliniquement significatif

1 très peu probable · 2 peu probable · 3 équivoque · 4 probable · 5 très probable. Biopsie ciblée en général à partir de 4 ; 3 : selon la densité de PSA (> 0,15–0,20 ng/mL/cm³) et le contexte.

QUALITÉ · PI-QUAL V2 (2024)

Échelle en 3 points
image inadéquate, adéquate ou optimale ; applicable à l'IRM multiparamétrique et sans injection (biparamétrique)

Critères
T2 dans 2 plans, diffusion sans artefact (b élevé, ADC), absence de gaz rectal ou de mouvement, DCE si réalisé

Préparation
vessie peu remplie, rectum vide (lavement ou régime), antispasmodique si pas de contre-indication

COMPTE RENDU

Prostate
volume (ellipsoïde), densité de PSA

Lésion index
localisation sur schéma à 41 secteurs, taille, scores T2, diffusion, DCE

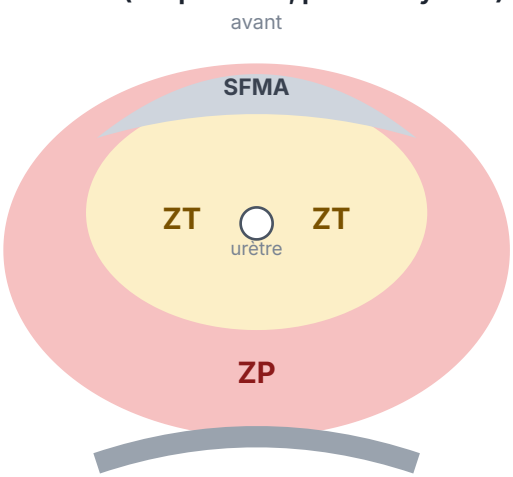
Extension
capsule, vésicules séminales, ganglions, os

Score final
PI-RADS par lésion (4 lésions au maximum) et PI-QUAL

Prostate · PI-RADS v2.1 (suite)

ATLAS VISUEL

Anatomie zonale (coupe axiale, partie moyenne)



- **Zone périphérique (ZP)** — ≈ 70 % des cancers · score par la DIFFUSION
- **Zone de transition (ZT)** — hypertrophie bénigne · score par le T2
- **Stroma fibromusculaire antérieur** — normalement hypo T2 et ADC bas
- **Zone centrale (base)** — hypo T2 symétrique : piège

Schémas simplifiés, non à l'échelle · SFMA = stroma fibromusculaire antérieur

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

PI-RADS
Radiopaedia · v2.1
radiopaedia.org/articles/prostate-imaging-report

Arbre décisionnel PI-RADS v2.1
Radiopaedia · schéma
radiopaedia.org/cases/pi-rads-v21-flowchart?lang

IRM prostatique : démarche
Radiopaedia · lecture par zone
radiopaedia.org/articles/prostate-mri-an-approac

PI-RADS 5 (cas)
Radiopaedia · cancer de la ZP
radiopaedia.org/cases/prostate-cancer-pi-rads-5-

Anatomie de la prostate
Radiopaedia · zones
radiopaedia.org/articles/prostate

Sources : ACR PI-RADS – www.acr.org/Clinical-Resources/Clinical-Tools-and-Reference/... · PI-RADS v2.1 zone de transition (BJR) – academic.oup.com/bjr/article/95/1131/20210916/7451470 · PI-QUAL v2 (Eur Radiol 2024) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11519155/ · The evolving PI-RADS paradigm (2026) – link.springer.com/content/pdf/10.1186/s40644-026-01035-7.pdf